Plantas medicinales para la alergia

Guía de acompañamiento del taller en vivo

Qué pasa en una alergia, qué plantas tienen evidencia para acompañarla, cómo usarlas con criterio y cuándo una planta no alcanza.

@mburucuya.hierbas

ÍNDICE

Contenidos de esta guía

1. Qué es una alergia
2. Sensibilización y reexposición: por qué no todos reaccionan igual
3. Vía respiratoria y vía piel: dos formas distintas de manifestarse
4. Los alérgenos más comunes
5. Cuándo es una urgencia médica (y las plantas dejan de aplicar)
6. Qué ofrece la farmacia: antihistamínicos y afines
7. Cuándo tomar las plantas: prevención y síntomas
8. Reforzar el sistema inmune no es lo mismo que calmar una alergia
9. Ortiga (Urtica dioica / Urtica urens)
10. Té verde (Camellia sinensis)
11. Llantén (Plantago lanceolata / major)
12. Perilla (Perilla frutescens)
13. Receta: infusión antihistamínica
14. Quercetina
15. Manzanilla por vía tópica y la familia de las Asteráceas
16. El mito de los vahos de eucalipto
17. Plantas respiratorias que no son antihistamínicas
18. Alergias en pediatría
19. ¿Combinar con el antihistamínico o reemplazarlo?
20. Histaminosis: no es lo mismo que una alergia
Preguntas frecuentes
Resumen: una guía rápida de decisión
21. Bibliografía

EL PUNTO DE PARTIDA

1. Qué es una alergia

Una alergia es una respuesta exagerada del sistema inmune frente a una sustancia que, en sí misma, no es peligrosa: un polen, una proteína de un alimento, el pelo de un animal. El sistema inmune la identifica por error como una amenaza y monta una respuesta de defensa que termina generando los síntomas que conocemos como alergia.

El protagonista de esa respuesta es el mastocito, una célula que está apostada en los tejidos que están en contacto directo con el exterior: piel, mucosa respiratoria, mucosa digestiva. Dentro del mastocito hay gránulos cargados de histamina y otros mediadores inflamatorios. Cuando el alérgeno aparece y el sistema inmune ya lo tiene "fichado" (ver el punto 2), el mastocito libera ese contenido de golpe: es lo que se llama degranulación.

La histamina liberada se une a receptores específicos (los receptores H1, principalmente) en los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas y el músculo liso de las vías respiratorias. Ahí aparecen los síntomas típicos: vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular (hinchazón, enrojecimiento, moqueo), estimulación de terminaciones nerviosas (picazón, estornudos) y, en las vías respiratorias, contracción del músculo liso (sensación de pecho cerrado, en los casos más marcados).

La idea clave

La mayoría de las plantas que vamos a ver en esta guía actúan, de una forma u otra, sobre este mismo mecanismo: bloqueando el receptor H1, estabilizando la membrana del mastocito para que libere menos histamina, o inhibiendo enzimas que amplifican la inflamación. Por eso conviene tener este esquema claro antes de pasar a cada planta en particular.

Un punto que suele quedar afuera de las explicaciones rápidas: la histamina no es la única sustancia que libera el mastocito. Junto con ella salen otros mediadores, como las prostaglandinas y los leucotrienos, que contribuyen a sostener la inflamación un rato después de que el pico de histamina ya bajó. Esto explica por qué un síntoma alérgico puede "quedar dando vueltas" varias horas, incluso con un antihistamínico ya tomado: la histamina está bloqueada, pero la inflamación de fondo tarda un poco más en resolverse.

Por último, vale la pena nombrar que la intensidad de la respuesta no depende solo del alérgeno en sí, sino también de la "carga alergénica" total que recibe una persona en un momento dado. Es el concepto de umbral: alguien con rinitis leve al polen puede, además, tener una mascota en casa y estar expuesto a ácaros, y es la suma de todos esos estímulos la que termina definiendo si los síntomas aparecen y con qué intensidad, más que un único alérgeno aislado.

UN PASO QUE SUELE FALTAR

2. Sensibilización y reexposición

Una pregunta que surge seguido es por qué alguien puede convivir años con un gato sin problema y, de un día para el otro, empezar a reaccionar. La respuesta está en que la alergia se arma en dos etapas, y la primera no da ningún síntoma.

Etapa 1 — Sensibilización

En el primer contacto con el alérgeno, el sistema inmune no reacciona todavía con síntomas: lo que hace es "aprenderlo". Un tipo de célula de defensa presenta ese alérgeno a los linfocitos B, que empiezan a fabricar anticuerpos de tipo IgE específicos contra esa sustancia puntual. Esos anticuerpos IgE se van a anclar en la superficie de los mastocitos, quedando como "centinelas" a la espera de un próximo encuentro con ese mismo alérgeno. Esta etapa puede durar meses o años, y no se nota.

Etapa 2 — Reexposición

Recién en un contacto posterior, cuando el alérgeno se encuentra con esos anticuerpos IgE ya anclados en los mastocitos, se dispara la degranulación y aparecen los síntomas. Por eso una persona puede sensibilizarse a los dos años de tener un gato en casa y no antes: no es que el gato "empezó" a producir alergia, es que recién ahí se completó el proceso de sensibilización.

Por qué importa para esta guía

Entender esto ayuda a explicar por qué una persona puede tener una reacción nueva a algo que toleró toda la vida, y por qué la exposición repetida a un alérgeno (aunque sea en dosis bajas) puede ir generando sensibilización con el tiempo, incluso sin que haya síntomas en el medio.

Esto también explica por qué una alergia puede aparecer en la adultez sin antecedentes previos, algo que suele generar extrañeza ("toda mi vida comí maní y nunca me pasó nada"). El sistema inmune no es estático: la sensibilización puede completarse en cualquier momento de la vida, frente a un alérgeno con el que ya hubo contacto muchas veces antes sin consecuencias.

Y en sentido contrario, también puede pasar que una sensibilización pierda intensidad con el tiempo si la exposición al alérgeno se reduce de forma sostenida, aunque esto varía mucho según la persona y el tipo de alérgeno, y no es algo sobre lo que una planta pueda influir.

DOS FORMAS DE MANIFESTARSE

3. Vía respiratoria y vía piel

El mismo mecanismo de fondo (mastocito, histamina, receptor H1) se expresa distinto según en qué tejido ocurra la degranulación. Reconocer esto ayuda a entender por qué una misma planta puede servir para un cuadro y no para otro, y por qué algunas formas de uso (oral, tópica, inhalatoria) tienen más sentido en un caso que en el otro.

Vía respiratoria

Rinitis alérgica (estornudos en salva, moqueo acuoso, picazón de nariz y ojos, congestión) y, en los cuadros más marcados, compromiso bronquial con sensación de pecho cerrado o sibilancias. Es la forma más frecuente en alergias estacionales (polen) y a ácaros.

Vía piel

Urticaria (ronchas que pican, que aparecen y desaparecen), dermatitis de contacto, angioedema localizado (hinchazón de una zona puntual, por ejemplo un párpado o un labio, que no compromete la respiración). Es la forma típica de alergias a alimentos, picaduras de insectos, níquel o cosméticos.

Esta distinción también ordena las formas de uso de las plantas: por vía oral (infusiones, cápsulas) para un efecto sistémico sobre la histamina circulante, que sirve tanto para cuadros respiratorios como cutáneos; y por vía tópica (compresas, cremas) para un efecto local, pensado sobre todo para piel.

¿Y la vía inhalatoria?

La vía inhalatoria (vahos, aceites esenciales) tiene sentido para despejar una mucosa congestionada por una infección, pero no es la vía indicada para un cuadro alérgico respiratorio, porque el estímulo directo de un aceite esencial sobre una vía aérea ya hiperreactiva puede empeorar el síntoma en lugar de mejorarlo. Este punto se retoma con más detalle en el punto 16, a propósito del eucalipto.

ANTES DE SEGUIR

4. Los alérgenos más comunes

Conocer los disparadores más frecuentes ayuda a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de "una alergia", porque el término agrupa cuadros con orígenes muy distintos.

Por inhalación

- Pólenes de gramíneas, árboles y malezas (el llantén es, él mismo, uno de los pólenes alergénicos más comunes — más sobre esto en el punto 11)
- Ácaros del polvo doméstico
- Esporas de hongos ambientales (humedad)
- Epitelio, saliva y orina de perros y gatos

Por contacto o ingesta

- Alimentos (maní, mariscos, leche, huevo, frutos secos, entre los más frecuentes)
- Picaduras de insectos (abejas, avispas)
- Látex
- Níquel y algunos cosméticos o fragancias, por contacto directo con la piel
- Ciertos medicamentos

5. Cuándo es una urgencia médica

Antes de hablar de ninguna planta, hay una distinción que tiene que quedar clara: no es lo mismo una alergia leve que una reacción alérgica grave, y las plantas de esta guía solo tienen sentido en el primer grupo.

Leve a moderada — ahí una planta puede acompañar

Estornudos, picazón de nariz, ojos o garganta, congestión, moqueo, algunas ronchas localizadas en la piel. Son molestos pero no comprometen funciones vitales.

Grave — urgencia médica, ninguna planta reemplaza esto

> Hinchazón de labios, lengua o garganta (edema de glotis); dificultad para respirar o sensación de cierre en la garganta; caída brusca de la presión arterial, mareo o pérdida de conocimiento; urticaria generalizada de aparición súbita junto con alguno de los signos anteriores. Este cuadro se llama anafilaxia y es una emergencia médica: requiere atención inmediata (adrenalina / guardia), no una infusión.

Las plantas que se desarrollan en esta guía están pensadas para acompañar cuadros leves a moderados, del tipo que se maneja habitualmente con un antihistamínico de venta libre. Ante cualquier signo de reacción grave, la prioridad es la atención médica de urgencia.

Una señal intermedia a vigilar

Entre el síntoma leve y la emergencia hay una zona intermedia que conviene vigilar: síntomas que no ceden con las medidas habituales, que empeoran rápido en lugar de estabilizarse, o que afectan a más de un sistema del cuerpo a la vez (por ejemplo, piel y digestivo juntos). Ahí, aunque no haya signos de anafilaxia, es momento de consultar y no de insistir con remedios caseros.

6. Qué ofrece la farmacia

Los antihistamínicos de venta libre o bajo receta actúan, en general, bloqueando el receptor H1 (el mismo que mencionamos en el punto 1), por eso frenan el efecto de la histamina ya liberada. Es el mismo blanco de acción que buscan varias de las plantas de esta guía, aunque con una potencia y una velocidad de acción distintas.

Vale la pena aclarar un punto que suele generar confusión: algunos productos combinados muy conocidos no son "solo" un antihistamínico. Por ejemplo, Dexalergin combina dexametasona (un corticoide) con clorfeniramina (un antihistamínico), no es un antihistamínico puro. Esto importa porque un corticoide tiene otro perfil de efectos y de uso que un antihistamínico solo, y conviene saber qué se está tomando.

Esta guía no reemplaza el criterio médico ni farmacéutico sobre qué antihistamínico usar: el objetivo es entender dónde se ubican las plantas en relación a esa opción, no sustituirla a ciegas.

Antihistamínicos de primera y segunda generación

Otro dato útil para entender el panorama: los antihistamínicos "clásicos" (primera generación) cruzan la barrera hematoencefálica y suelen dar somnolencia marcada, mientras que los más modernos (segunda generación) fueron diseñados específicamente para minimizar ese efecto sedante. Esta diferencia no tiene que ver con las plantas de esta guía, pero ayuda a entender por qué dos antihistamínicos pueden sentirse tan distintos en el cuerpo.

UN PUNTO QUE CAMBIA EL RESULTADO

7. Cuándo tomar las plantas

El momento en el que se empieza a tomar una planta cambia mucho lo que se puede esperar de ella. Conviene distinguir dos lógicas de uso:

Uso preventivo (antes de la temporada)

Para quien ya sabe que todos los años, en una época del año puntual, tiene síntomas (por ejemplo, alergia estacional al polen), empezar a tomar la planta unas semanas antes de que arranque esa temporada puede ayudar a que el cuadro sea más leve cuando llegue. Esto tiene más sentido con plantas que se toman de forma sostenida en el tiempo.

Uso ante el síntoma (una vez que ya apareció)

También pueden tomarse una vez que el síntoma ya está presente, como acompañamiento del cuadro agudo. Ahí el efecto suele ser más gradual que el de un antihistamínico farmacológico, por eso no conviene esperar un alivio tan inmediato.

En síntesis

Las plantas de esta guía sirven tanto como prevención (tomadas con anticipación en quien ya conoce su patrón estacional) como de acompañamiento una vez que el síntoma apareció, pero en ambos casos para cuadros leves a moderados.

UN PUNTO QUE CONVIENE ACLARAR

8. Reforzar el sistema inmune no es calmar una alergia

Es común escuchar hablar de "fortalecer las defensas" y de "calmar una alergia" como si fueran la misma idea, porque las dos mencionan al sistema inmune. Son objetivos opuestos.

Plantas como la equinácea o la ashwagandha están pensadas para estimular un sistema inmune que está poco activo, como en cuadros de defensas bajas o resfríos a repetición. En una alergia pasa lo contrario: el sistema inmune ya está reaccionando de más frente a algo que no es una amenaza real. Ahí lo que se busca no es estimularlo, sino bajar esa respuesta exagerada.

Por eso una planta pensada para "reforzar las defensas" no tiene el efecto buscado en una alergia, y en algunos casos ni siquiera es la lógica correcta para ese cuadro.

Esta confusión es muy frecuente porque, en el lenguaje cotidiano, "sistema inmune fuerte" suena siempre a algo positivo. Pero en una alergia el sistema inmune no está débil: está reaccionando de más frente a algo inofensivo. Estimularlo todavía más con una planta inmunoestimulante no corrige ese error de interpretación, y en teoría podría incluso intensificarlo.

La recomendación práctica es simple: si el objetivo es acompañar una alergia, pensar en plantas que modulen o calmen la respuesta (como las que se desarrollan desde el punto 9), y reservar las plantas inmunoestimulantes para otros contextos, como resfríos a repetición o épocas de mayor exposición a virus respiratorios.

MONOGRAFÍA

9. Ortiga

Urtica dioica y *Urtica urens* — Urticaceae

La ortiga es, probablemente, la planta antihistamínica por excelencia dentro de la fitoterapia. Su monografía en la EMA (European Medicines Agency) la reconoce para el alivio sintomático de molestias articulares menores y, por uso tradicional, como diurético; su uso antialérgico está respaldado sobre todo por estudios farmacológicos e in vitro, y por un uso tradicional muy extendido.

Mecanismo de acción

- Bloqueo del receptor H1, de forma similar (aunque más suave) a un antihistamínico farmacológico (Roschek et al., 2009).
- Inhibición de la degranulación del mastocito, es decir, actúa también "antes", reduciendo la liberación de histamina.
- Inhibición de COX-1 y COX-2, lo que suma un efecto antiinflamatorio adicional (Mittman, 1990).

Composición de interés

Flavonoides, sales minerales (hierro, calcio, sílice, azufre, potasio), ácidos fenólicos, glucoproteínas y clorofila. Esta riqueza mineral es también la base de su uso tradicional como planta remineralizante.

Otras acciones descriptas

Además de su efecto antihistamínico, a la ortiga se le reconocen propiedades antiinflamatorias, hipoglucemiantes, hepatoprotectoras y diuréticas, lo cual explica su presencia en formulaciones para otros usos además del alérgico.

Preparación habitual

15 g de hoja seca por litro de agua, en infusión.

Precauciones y contraindicaciones

Puede potenciar el efecto de antihiperglucemiantes, antihipertensivos y sedantes.
Aumenta el efecto del diclofenac.
Puede producir molestias gastrointestinales.
Evitar en el embarazo y la lactancia.
Evitar si hay alergia conocida a otras plantas de la familia Urticaceae.

¿Qué ortiga se puede consumir?

En la naturaleza pueden encontrarse distintas especies de ortiga. Las dos más comunes en nuestra región son:

- **Urtica dioica** (ortiga mayor): planta perenne, de mayor porte. Es la especie más estudiada y la que más habitualmente se vende seca en dietéticas.
- **Urtica urens** (ortiga menor): planta anual, de porte más pequeño, frecuente en huertas y jardines caseros.

Ambas pican en fresco por los mismos pelos urticantes, y ambas son seguras una vez secas. Si hay dudas sobre la identificación en el campo, la recomendación es comprarla seca y de procedencia conocida.

En la práctica

Al ser una planta de efecto gradual, no está pensada para un alivio inmediato tipo "tomo una taza y en 20 minutos se me pasa": su lugar es más el de un acompañamiento sostenido, tomada varias veces al día durante el período en que hay síntomas, o de forma preventiva en las semanas previas a una temporada conocida. Si después de varios días de uso constante no se nota ninguna mejoría, no tiene sentido seguir aumentando la dosis esperando otro resultado.

MONOGRAFÍA

10. Té verde

Camellia sinensis — Theaceae

El té verde es conocido sobre todo como estimulante y antioxidante, pero una de sus catequinas, la EGCG (epigalocatequina galato), tiene evidencia de efecto antialérgico en estudios clínicos realizados en Japón, donde se evaluó su impacto sobre los síntomas de la rinitis alérgica estacional.

Mecanismo de acción

La EGCG actúa inhibiendo la liberación de histamina desde el mastocito y modulando la respuesta inflamatoria asociada a los procesos alérgicos, sumado a su conocido efecto antioxidante general.

Composición de interés

Bases xánticas (cafeína), flavonoides, taninos, antocianidinas y catequinas (entre ellas, la EGCG).

Otras acciones descriptas

Estimulante del sistema nervioso central, actúa sobre el GABA, hipertensivo, genera vasodilatación periférica. Por su contenido de cafeína, puede desencadenar migrañas en personas sensibles.

Preparación habitual

Aproximadamente 10 g por litro de agua, en infusión.

Precauciones y contraindicaciones

Interacciones descriptas con fenobarbital, benzodiacepinas, IMAO, anticoagulantes, betabloqueantes, metotrexato, algunos antibióticos y cimetidina.
En exceso puede producir molestias gástricas.
No tomarlo junto con las comidas: interfiere con la absorción del hierro.
Evitar en trastornos del sistema nervioso.
Precaución en el embarazo y la lactancia, por su contenido de cafeína.

En la práctica

Por su contenido de cafeína, conviene evitar tomarlo sobre la tarde-noche en personas sensibles a estimulantes, y tenerlo en cuenta si ya se toma café, mate o algún otro estimulante durante el día, para no sumar más cafeína de la que esa persona tolera cómodamente.

MONOGRAFÍA

11. Llantén

Plantago lanceolata / *Plantago major* — Plantaginaceae

El llantén tiene un uso tradicional muy conocido para las vías respiratorias: por su contenido de mucílagos y su efecto expectorante y antiinflamatorio de la mucosa, se usa tradicionalmente en tos y procesos bronquiales, con estudios que muestran mejoras en parámetros espirométricos (FEV1/FVC) en algunos contextos respiratorios.

El dato que suele sorprender

> El polen de llantén es, él mismo, uno de los alérgenos estacionales más frecuentes: representa entre un 20 y un 30% de los casos de rinitis alérgica estacional en las regiones donde esta planta es común. Es decir: la misma planta que tradicionalmente se usa para acompañar síntomas respiratorios es, para otra persona, la causa de su alergia.

Esto no contradice su uso: la planta (hoja, en infusión) y el polen (que se libera al aire en la floración) son exposiciones distintas. Pero sí es un punto a tener en cuenta en personas con alergia estacional diagnosticada a gramíneas o malezas, por el riesgo de reactividad cruzada.

Composición de interés

Mucílagos, iridoides (aucubina), taninos y flavonoides.

Precauciones y contraindicaciones

> Precaución en personas con alergia conocida a pólenes de gramíneas o malezas, por posible reactividad cruzada.
> En general bien tolerado; pueden darse molestias gastrointestinales ocasionales.

MONOGRAFÍA

12. Perilla

Perilla frutescens — Lamiaceae

La perilla es una planta de uso culinario y medicinal muy extendido en la medicina tradicional asiática, con evidencia clínica interesante sobre su efecto en la rinitis alérgica. Un ensayo clínico aleatorizado (Takano et al., 2004) evaluó un extracto de perilla en personas con rinitis alérgica estacional, encontrando mejoras en los síntomas frente a placebo.

Mecanismo de acción

Sus compuestos (entre ellos, el ácido rosmarínico) actúan inhibiendo la liberación de histamina y modulando mediadores inflamatorios implicados en la respuesta alérgica.

Una aclaración honesta

La perilla no es una planta habitual en las dietéticas argentinas, a diferencia de la ortiga, el té verde o el llantén. Se incluye en esta guía por su respaldo clínico, pero conseguirla puede requerir buscarla en comercios especializados o bajo otras presentaciones.

Vale la pena conocerla igual, más allá de su disponibilidad actual: es un buen ejemplo de que la fitoterapia con evidencia clínica no se agota en las plantas más vendidas en una dietética de barrio, y de que vale la pena seguir de cerca la bibliografía, porque la oferta de plantas disponibles va cambiando con el tiempo.

RECETA PROPIA

13. Infusión antihistamínica

Esta es la infusión que preparo habitualmente combinando tres de las plantas ya descriptas, aprovechando que actúan sobre el mismo mecanismo (bloqueo de H1 e inhibición de la degranulación del mastocito) desde ángulos distintos.

Ingredientes (por taza, 400 ml de agua)

- 1 cucharadita (aprox. 2 g) de llantén
- 1 cucharadita (aprox. 2 g) de ortiga
- 1 cucharadita (aprox. 2 g) de té verde

Preparación

Macerar las tres hierbas en 400 ml de agua durante 15 minutos. Colar. Tomar sin azúcar, hasta 4 tazas por día.

Conservación

Preparar idealmente en el momento. Si no es posible, se conserva hasta 2 horas a temperatura ambiente o hasta 48 horas en la heladera.

Importante
Esta infusión es para adultos. No está recomendada para uso pediátrico (ver el punto 18).

MONOGRAFÍA

14. Quercetina

La quercetina es un flavonoide presente en muchos alimentos vegetales (cebolla, manzana, cítricos, entre otros) con efecto estabilizador de la membrana del mastocito: reduce la cantidad de histamina que se libera frente al alérgeno, además de tener acción antioxidante y antiinflamatoria general.

Un punto honesto

No alcanza con "comer cebolla" para lograr un efecto antialérgico relevante: las dosis usadas en los estudios que muestran beneficio son bastante más altas que las que se obtienen con la alimentación habitual, por lo que en general se recurre a suplementos concentrados.

Precauciones y contraindicaciones

Puede interactuar con medicamentos metabolizados por la enzima CYP3A4.
Puede potenciar el efecto de anticoagulantes.
En dosis altas se han descripto dolor de cabeza y hormigueo.
Precaución en el embarazo y la lactancia.

En la práctica

Al tratarse de un suplemento concentrado y no de un alimento, conviene elegir productos de procedencia confiable y respetar la dosis indicada en el envase, ya que la concentración puede variar bastante entre marcas.

VÍA TÓPICA

15. Manzanilla y la familia de las Asteráceas

La manzanilla (*Matricaria chamomilla*) es una de las plantas más usadas por vía tópica para acompañar irritaciones leves de piel, incluidas las de origen alérgico. Su acción pasa en buena parte por el camazuleno, un compuesto que se forma durante la destilación y que inhibe la liberación de histamina a nivel local, sumado a un efecto antiinflamatorio general.

Advertencia por reactividad cruzada

La manzanilla pertenece a la familia de las Asteráceas (Compuestas), la misma familia que la ambrosía, el crisantemo y otras plantas con alto potencial alergénico. En personas con alergia conocida a esta familia de plantas, la manzanilla puede generar una reacción cruzada en lugar de aliviar el síntoma. Ante dermatitis de contacto o antecedentes de alergia a Asteráceas, no se recomienda su uso tópico sin antes probarlo en una zona pequeña de piel.

Una forma simple de probar tolerancia antes de aplicar una compresa de manzanilla en una zona extensa de piel es dejar actuar una compresa tibia sobre una zona pequeña (por ejemplo, el antebrazo) y esperar 20 a 30 minutos, observando si aparece enrojecimiento, picazón o hinchazón en esa zona antes de usarla en la zona que realmente molesta.

UN MITO PARA DESARMAR

16. El mito de los vahos de eucalipto

El eucalipto es una planta muy usada tradicionalmente en vahos para descongestionar la nariz durante un resfrío común, y ahí tiene sentido: su componente principal, el 1,8-cineol, tiene efecto descongestivo y mucolítico sobre una mucosa inflamada por una infección viral.

Por qué no es buena idea en alergia respiratoria o asma

En personas con asma o con hiperreactividad de la vía aérea (algo frecuente en quienes tienen alergias respiratorias), la inhalación de vapores con aceites esenciales como el eucalipto puede actuar como irritante directo de una vía aérea ya sensibilizada y desencadenar broncoespasmo, es decir, empeorar el cuadro en lugar de aliviarlo.

La diferencia está en el tipo de inflamación: en un resfrío común la mucosa está inflamada por una infección, y el efecto descongestivo ayuda; en una vía aérea con hiperreactividad alérgica, el mismo estímulo puede leerse como una agresión más y gatillar una respuesta defensiva del músculo bronquial.

UN MATIZ IMPORTANTE

17. Plantas respiratorias que no son antihistamínicas

No toda planta usada tradicionalmente para "lo respiratorio" sirve para una alergia, porque puede estar actuando por un mecanismo completamente distinto al de la histamina.

Ejemplo: infusión antiasmática (ambay, lavanda, gordolobo)

Es otra combinación de uso tradicional, pensada para acompañar cuadros de broncoespasmo o asma, que actúa principalmente relajando el músculo liso bronquial y favoreciendo la expectoración, no bloqueando receptores de histamina ni estabilizando mastocitos. Es decir: tiene una lógica de acción distinta a la de la infusión antihistamínica del punto 13, aunque las dos "sirvan para respirar mejor" en sentido amplio.

Por qué importa la distinción

Usar una planta antiasmática esperando un efecto antihistamínico (o al revés) puede llevar a una desilusión con la fitoterapia en general, cuando en realidad el problema fue elegir la planta equivocada para ese mecanismo puntual. Antes de recomendar o tomar una planta "para lo respiratorio", vale la pena preguntarse: ¿el síntoma es por alergia (histamina) o por otra causa (infección, broncoespasmo de otro origen)?

Esto aplica a muchas otras combinaciones tradicionales "para lo respiratorio" más allá de la mencionada: antes de usar cualquier planta por esa vía, vale la pena identificar primero qué tipo de síntoma respiratorio se quiere acompañar y recién después elegir la planta en función de ese mecanismo, en lugar de guiarse solo por la fama general de "sirve para respirar".

UN PÚBLICO APARTE

18. Alergias en pediatría

En niños y niñas, el abordaje con plantas para alergias es mucho más acotado que en adultos. No existe, dentro del uso tradicional y la evidencia disponible, una recomendación de planta antihistamínica para uso pediátrico equivalente a la infusión del punto 13.

En pediatría, el catálogo de plantas respiratorias queda limitado a acompañar síntomas de moco o catarro (resfríos comunes), no a cuadros alérgicos. Ante una sospecha de alergia en un niño o una niña, la recomendación siempre es consultar primero al pediatra.

> Ninguna de las plantas o recetas de esta guía (en particular, la infusión antihistamínica del punto 13) está pensada ni recomendada para uso pediátrico.

Esto no significa que no haya nada para hacer: medidas no farmacológicas como ventilar la casa, lavar la ropa de cama con agua caliente, evitar el contacto directo con la mascota en la cama, o usar solución fisiológica para higiene nasal, son recursos seguros en niños y niñas que pueden ayudar a reducir la exposición al alérgeno mientras se define el tratamiento con el pediatra.

UNA PREGUNTA FRECUENTE

19. ¿Combinar con el antihistamínico o reemplazarlo?

No hay evidencia de riesgos específicos conocidos por combinar las plantas de esta guía con un antihistamínico farmacológico indicado por un médico, pero tampoco existen estudios que hayan evaluado esa combinación puntual, así que no puede afirmarse que sea equivalente ni que potencie el efecto.

Como criterio general: en síntomas leves, una planta puede alcanzar por sí sola para sentirse mejor. En síntomas moderados a severos, el antihistamínico sigue siendo la primera línea, y la planta puede sumarse como acompañamiento, no como reemplazo.

Una recomendación práctica para quien quiere probar reemplazar temporalmente el antihistamínico por una planta: hacerlo en un período de síntomas conocidos y manejables (no en el pico de una reacción fuerte), y tener claro de antemano cuál es la señal para volver al antihistamínico o consultar, en lugar de insistir con la planta si el síntoma no mejora o empeora.

PARA NO CONFUNDIR

20. Histaminosis: no es lo mismo que una alergia

La histaminosis (o intolerancia a la histamina) es un cuadro distinto de la alergia, aunque comparte protagonista: en lugar de una respuesta inmune mediada por IgE frente a un alérgeno puntual, es una dificultad para degradar correctamente la histamina que ya está presente en el organismo o que se ingiere con ciertos alimentos (quesos curados, embutidos, vino, pescado en conserva, entre otros), generando síntomas parecidos a los de una alergia (dolor de cabeza, rubor, molestias digestivas, picazón) sin que haya un alérgeno externo de por medio.

Un detalle relevante para esta guía

Los tricomas (pelitos) de la ortiga fresca contienen histamina en su composición. El secado reduce esa cantidad considerablemente, pero la tolerancia individual puede variar. En personas con histaminosis diagnosticada, vale la pena prestar atención a cómo responde el cuerpo incluso a la ortiga seca.

DUDAS HABITUALES

Preguntas frecuentes

¿Puedo tomar la infusión antihistamínica todos los días durante toda la temporada de alergia?

Sí, es una infusión pensada justamente para un uso sostenido durante el período en que hay síntomas, respetando la dosis máxima indicada (hasta 4 tazas por día) y las contraindicaciones de cada una de sus tres plantas (punto 13).

¿Las plantas de esta guía interactúan entre sí si las combino?

No hay evidencia de riesgos conocidos por combinar las plantas que se describen acá entre ellas, como ya se usa en la infusión antihistamínica. Lo que sí hay que revisar es la lista de interacciones de cada planta con medicamentos, que se detalla en cada monografía.

¿Cuánto tardan en hacer efecto?

A diferencia de un antihistamínico farmacológico, el efecto de estas plantas suele ser gradual: no conviene esperar un alivio en minutos. Tomadas de forma preventiva, el efecto se nota más sobre la intensidad general de la temporada que sobre un síntoma puntual.

Si una planta no me hizo nada, ¿quiere decir que no sirve para nadie?

No necesariamente. La respuesta individual varía, y en fitoterapia es habitual que una planta le funcione muy bien a una persona y poco a otra. Lo que sí es una señal clara es que, si no hay ninguna mejoría después de un uso sostenido y correcto, no tiene sentido seguir escalando la dosis: ahí conviene replantear el abordaje, no insistir con más cantidad.

ANTES DE CERRAR

Resumen: una guía rápida de decisión

Para tener todo junto a mano, acá va un resumen de los puntos más importantes de esta guía:

- Si hay hinchazón de labios, lengua o garganta, dificultad para respirar o caída de presión: urgencia médica, ninguna planta reemplaza esto (punto 5).
- Si el síntoma es leve a moderado (estornudos, picazón, congestión, ronchas localizadas): una planta puede acompañar.
- Para un efecto sistémico (oral): ortiga, té verde, llantén, perilla o quercetina, solas o combinadas como en la infusión antihistamínica (punto 13).
- Para un efecto local en piel: manzanilla por vía tópica, con precaución si hay alergia conocida a Asteráceas.
- En niños y niñas: no hay planta antihistamínica recomendada, consultar siempre al pediatra.
- "Reforzar el sistema inmune" (equinácea, ashwagandha) no es lo mismo que calmar una alergia: son objetivos opuestos.
- El efecto de las plantas antihistamínicas es gradual, no inmediato: tienen más sentido como acompañamiento sostenido que como solución de urgencia.

21. Bibliografía y fuentes de referencia

• European Medicines Agency (EMA) — Community herbal monograph on *Urtica dioica* L., *Urtica urens* L., folium.

• European Medicines Agency (EMA) — Community herbal monograph on *Plantago lanceolata* L., folium.

• Commission E (Comisión E alemana) — Monografías de *Urtica* spp., *Camellia sinensis*, *Matricaria chamomilla*.

• Roschek B. Jr. et al. (2009). "Nettle extract (*Urtica dioica*) affects key receptors and enzymes associated with allergic rhinitis." *Phytotherapy Research*.

• Mittman P. (1990). "Randomized, double-blind study of freeze-dried *Urtica dioica* in the treatment of allergic rhinitis." *Planta Medica*.

• Takano H. et al. (2004). "Extract of *Perilla frutescens* enriched for rosmarinic acid, a polyphenolic phytochemical, inhibits seasonal allergic rhinoconjunctivitis in humans." *Experimental Biology and Medicine*.

• Estudios clínicos japoneses sobre EGCG (epigalocatequina galato) de *Camellia sinensis* y su efecto en síntomas de rinitis alérgica estacional.

• Bibliografía general de fitoterapia y farmacognosia utilizada como referencia de composición química, mecanismos de acción y precauciones: monografías de quercetina, perfiles de interacción y reactividad cruzada entre pólenes y plantas de la familia Asteraceae.

Esta guía tiene fines informativos y de divulgación científica. No reemplaza una consulta médica. Ante síntomas moderados a severos, o cualquier signo de reacción alérgica grave, consultá con un profesional de la salud.

@mburucuya.hierbas